2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE PÉ DIABÉTICO PARA PROFISSIONAIS DA APS: UMA EXPERIÊNCIA DENTRO DO INTERNATO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

AGDA ROSE BEZERRA ALVES AQUINO[1], MARYANNE MARIA SIMPLICIO SANTOS[2], VINICIUS TENÓRIO COSTA VIEIRA[2], SHAUANNY DE SOUZA SILVA[3], ROBERTA DE ALBUQUERQUE WANDERLEY[2]

[1] CESMAC
[2] UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL), Campus Arapiraca
[3] UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL), Campus AC Simões

- 📌 **Padronização da avaliação do pé diabético na APS.**
- 📌 **Instrumento baseado em evidências e adaptado ao território.**
- 📌 **Estratégia formativa com impacto na organização do cuidado.**
- 📌 **Potencial de prevenção de amputações evitáveis.**

Imagem 1: Capa do protocolo assistencial "Avaliação do Pé Diabético na APS" (Fonte: Simplício Santos *et al.*, 2026)

Introdução

O pé diabético é uma das possíveis complicações provocadas pelo Diabetes Mellitus (DM), e destaca-se por sua associação a ulcerações, infecções, hospitalizações e amputações evitáveis, com impacto na morbimortalidade e qualidade de vida do paciente com DM.

Na Atenção Primária à Saúde (APS), a identificação precoce de fatores de risco é fundamental para prevenção de agravos e organização do cuidado longitudinal. O Ministério da Saúde recomenda a avaliação periódica dos pés como parte do acompanhamento clínico e da estratificação de risco, compondo o indicador C4 de qualidade e financiamento da APS.

Durante o internato médico, integrado à Residência em Medicina de Família e Comunidade (MFC), identificou-se, em UBS de Arapiraca-AL, que atende população urbana de alta vulnerabilidade social, a necessidade de padronizar essa avaliação por meio de instrumento estruturado e adaptado ao serviço.

Objetivos

Elaborar instrumento padronizado, para equipe medica e de enfermagem, para avaliação clínica dos pés de pessoas com DM, com estratificação de risco e fluxos de encaminhamento, contribuindo para a sistematização do cuidado na APS.

Métodos

Relato de experiência sobre a construção de protocolo assistencial na UBS Cacimbas, em Arapiraca-AL, no contexto do internato e da Residência em MFC, a partir de revisão bibliográfica e análise de diretrizes do Ministério da Saúde. Elaborou-se, então, um protocolo adaptado ao serviço, com avaliação clínica, estratificação de risco, orientações preventivas e fluxos de encaminhamento.

Resultados

Desenvolveu-se instrumento assistencial com linguagem objetiva e aplicável à rotina da UBS, contemplando roteiro para registro em SOAP, fluxograma de avaliação sistematizada, classificação de risco, fluxos de encaminhamento e orientações de autocuidado.

Considerações finais

A experiência evidenciou que o internato integrado à Residência em MFC favorece o diagnóstico situacional e a construção coletiva de instrumentos baseados em evidências e adequados à realidade local. O instrumento representa avanço para padronizar a avaliação do pé diabético e qualificar o cuidado à pessoa com DM em contexto de alta vulnerabilidade social.

Imagem 2: Elucidação da avaliação de neuropatia com uso de monofilamento de 10g (Fonte: Simplício Santos *et al.*, 2026)

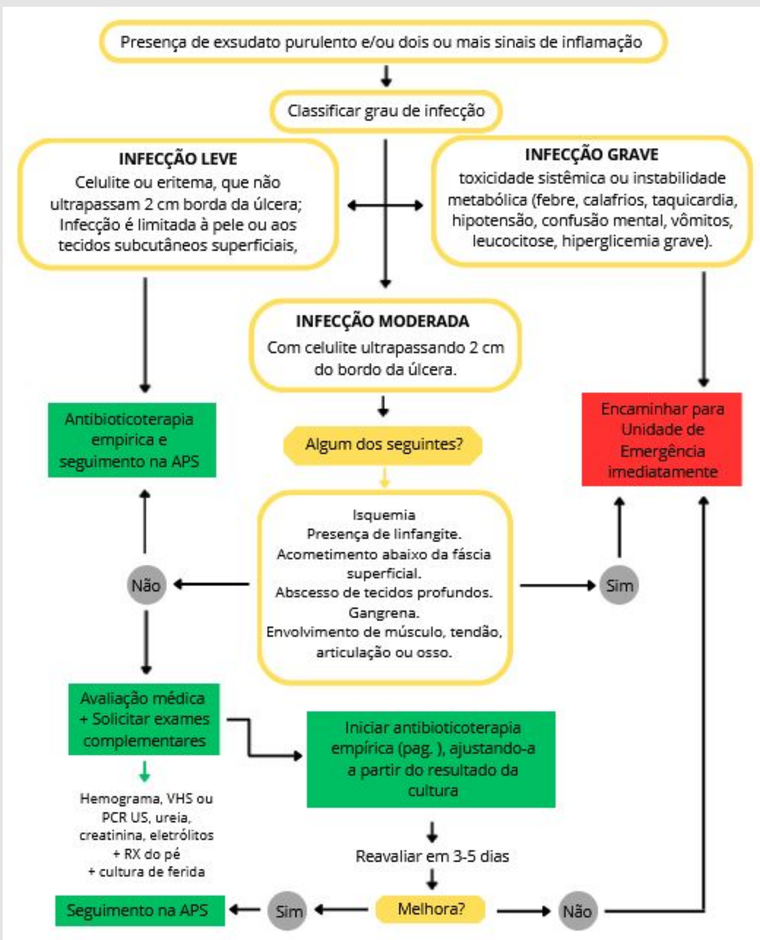

Imagem 3: Fluxograma para avaliação e fluxo de paciente com pé diabetico e úlcera infectada (Fonte: Simplício Santos *et al.*, 2026)

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MFC, CESMAC, BRASIL
AGDA ROSE BEZERRA ALVES AQUINO
MÉDICA RESIDENTE EM MFC

E-mail: agdarosealves@gmail.com
Contatos: (82) 999606558